KIT 6 – AVC / DÉFICIT NEUROLÓGICO AGUDO

Referências: ABRAMEDE 2024 • Ministério da Saúde 2023 • SBDCV • AHA/ASA Guidelines 2021

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem em pacientes com suspeita de **acidente vascular cerebral (AVC)** ou **déficit neurológico agudo**, priorizando o diagnóstico rápido, a estratificação de risco e o encaminhamento adequado para tratamento trombolítico ou neurocirúrgico.

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Avaliar **início do quadro, tempo de evolução e sintomas neurológicos focais** (hemiparesia, disartria, afasia, hemianopsia, vertigem, ataxia, alteração de consciência).
- Identificar **janela terapêutica**: até **4h30min** para trombólise venosa e até **24h** para trombectomia (casos selecionados).
- Aplicar **Escore NIHSS** para avaliação de gravidade.
- Realizar **ABCDE da emergência**, estabilizando via aérea e oxigenação.
- Iniciar protocolo de **AVC / Código AVC** se tempo de início ≤ 6 horas.

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Glicemia capilar imediata	Todos os pacientes com déficit neurológico agudo.	—
Hemograma completo	Todos os casos suspeitos de AVC (descartar infecção, anemia, trombocitopenia).	—
Eletrólitos / Ureia / Creatinina	Avaliar função renal, distúrbios hidroeletrolíticos e preparo para contraste.	Casos leves sem indicação de imagem contrastada.
Coagulograma (TP, TTPA, INR)	Obrigatório antes da trombólise e em uso de anticoagulantes.	Casos sem risco de sangramento e sem uso de anticoagulantes.
Glicemia sérica / Gasometria	Avaliação metabólica em pacientes graves, rebaixados ou hipoglicêmicos.	Casos leves e conscientes com glicemia capilar normal.
TGO / TGP / Bilirrubinas / FA	Avaliação hepática antes da trombólise em pacientes com comorbidades.	Casos leves, sem hepatopatia.
Troponina / CK-MB	Avaliação de injúria miocárdica associada (AVC cardiogênico).	Sem sintomas cardíacos.
PCR / Procalcitonina	Avaliação de infecção concomitante (pneumonia aspirativa, sepse).	Casos puros de AVC sem infecção.
Beta-hCG	Mulheres em idade fértil.	—

3. EXAMES DE IMAGEM
a) Primeira linha (emergencial / até 20 min)

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
TC de crânio sem contraste	Exame **obrigatório e prioritário** em todo paciente com déficit neurológico agudo para diferenciar AVC isquêmico de hemorrágico.	Nenhum caso suspeito deve deixar de realizar TC inicial.
RX de tórax	Avaliação complementar em pacientes graves, acamados ou com instabilidade respiratória.	Casos leves sem repercussão clínica.
ECG de 12 derivações	Avaliar arritmias (FA), isquemia, causa cardiogênica do AVC.	—

b) Segunda linha (confirmatória ou complementar)

Exame	Indicação (Solicitar se)	Evitar / Não Indicado
Angio-TC de crânio e vasos cervicais (carótidas e vertebrais)	Avaliar oclusão de grandes vasos e elegibilidade para trombectomia mecânica.	Casos de AVC lacunar ou já fora da janela terapêutica.
TC de perfusão cerebral	Identificação de penumbra isquêmica (avaliação do tecido viável).	Casos com diagnóstico e conduta já definidos.

4. ESCORES DE APOIO À DECISÃO

NIHSS – National Institutes of Health Stroke Scale

- Escore clínico utilizado para determinar gravidade do AVC.
- **Classificação:**
  - Leve: ≤ 4
  - Moderado: 5–15
  - Grave: > 15

Escala de Rankin modificada (mRS)

- Avaliação funcional e prognóstica no momento da admissão e alta.

Janela terapêutica para trombólise

Terapia	Critérios principais
Trombólise endovenosa (rtPA)	Até 4h30 do início dos sintomas; TC sem sangramento; PAS < 185 mmHg; ausência de contraindicações.
Trombectomia mecânica	Até 24h (casos selecionados com penumbra viável em angio/perfusão TC).

5. PRIORIDADES

- **TC de crânio sem contraste deve ser solicitada imediatamente**, idealmente em até 20 minutos da chegada.
- **Evitar exames laboratoriais desnecessários** que atrasem a trombólise.
- **Realizar ECG e glicemia capilar imediatos.**

- **Avaliar contra-indicações absolutas** antes da trombólise.
- Em caso de **deterioração neurológica súbita**, repetir **TC de crânio**.
- Garantir registro do **tempo de início dos sintomas (Last Seen Well)** e **tempo porta-TC / porta-agulha**.

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
Suspeita de AVC isquêmico (< 6h)	Glicemia, hemograma, coagulograma, eletrólitos, função renal	TC sem contraste ± Angio-TC
Suspeita de AVC hemorrágico	Hemograma, coagulograma, função renal	TC sem contraste (diagnóstico e volume)
AVC fora da janela / AIT	Exames metabólicos e infecciosos básicos	TC sem contraste ± RM com difusão
Déficit neurológico agudo sem foco definido	Hemograma, eletrólitos, gasometria, PCR, função renal	TC ± TC de perfusão / RM se disponível
Paciente com deterioração / piora súbita	Lactato, gasometria, função orgânica	TC de controle

Conclusão

A avaliação rápida e estruturada do paciente com déficit neurológico agudo é determinante para o prognóstico funcional. A priorização da **TC de crânio sem contraste** e a coleta apenas dos exames essenciais evitam atrasos no tratamento trombolítico.

✅ Diagnóstico rápido e preciso
✅ Menor atraso para trombólise ou trombectomia
✅ Uso racional de exames laboratoriais
✅ Melhor desfecho neurológico e prognóstico funcional